

DANS CE SUJET

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→

Perte brutale de la vision

→

Anisocorie

→

Vision trouble

→

Diplopie

→

Œdème des paupières

→

Douleur oculaire

→

Corps flottants

→

Exophtalmie

→

Œil rouge

→

Larmoiement

→

Autres symptômes oculaires

Perte brutale de la vision

Par **Christopher J. Brady**, MD, Larner College of Medicine, University of Vermont
Reviewed By **Sunir J. Garg**, MD, FACS, Thomas Jefferson University
Vérifié/Révisé oct. 2025

Physiopathologie | Étiologie | Bilan | Traitement | Points clés | Multimédia

La perte de vision aiguë est définie comme une réduction rapide de l'acuité visuelle survenant en quelques secondes à quelques jours. Elle peut affecter un seul ou les deux yeux ainsi qu'une partie ou la totalité du champ visuel. Les patients qui présentent de petites anomalies du champ visuel (p. ex., causées par un petit décollement de la rétine) peuvent décrire leurs symptômes comme une vision trouble.

Physiopathologie de la perte de vision aiguë

La perte de vision brutale a 3 causes générales:

- Une opacification des structures normalement transparentes que les rayons lumineux traversent pour atteindre la rétine (p. ex., cornée, vitré)
- Des anomalies rétinienne
- Des troubles affectant le nerf optique ou les voies visuelles

Étiologie de la perte de vision aiguë

Parmi les causes les plus importantes de perte de vision aiguë, on trouve:

- Les occlusions vasculaires de la rétine ([occlusion de l'artère centrale de la rétine](#), [occlusion de la veine centrale de la rétine](#))
- Une neuropathie optique ischémique (souvent en cas d'[artérite temporale](#))
- Une hémorragie dans le vitré (causée par une [rétinopathie diabétique](#) ou un traumatisme)
- Un [traumatisme](#)

En outre, la prise de conscience soudaine de la perte visuelle (perte visuelle faussement brutale) peut se manifester initialement comme une installation brutale. Par exemple, un patient qui présente une réduction visuelle de longue date dans un œil (probablement causée par une [cataracte](#) épaisse) prend soudainement conscience de la réduction visuelle dans l'œil atteint lorsqu'il cache l'œil normal.

La présence ou l'absence de douleur permet de catégoriser la perte de vision (voir tableau [Certaines causes de perte brutale de la vision](#)).

La plupart des troubles qui entraînent la perte totale de la vision quand ils affectent l'œil entier peuvent n'affecter qu'une partie de l'œil et ne provoquer qu'une anomalie du champ visuel (p. ex., l'occlusion d'une branche de l'artère ou de la veine centrale de la rétine, un [décollement localisé de la rétine](#)).

Les causes moins fréquentes de perte brutale de la vision comprennent:

- [L'uvéite antérieure](#) (affection fréquente, mais qui provoque habituellement des douleurs oculaires suffisamment importantes pour déclencher un bilan avant la perte de la vision)
- Rétinite agressive
- Certaines substances (p. ex., le méthanol, les pesticides [1])

Référence pour l'étiologie

1. [Souza Monteiro de Araújo D, Brito R, Pereira-Figueiredo D, et al. Retinal Toxicity Induced by Chemical Agents. Int J Mol Sci. 2022;23\(15\):8182. Published 2022 Jul 25. doi:10.3390/ijms23158182](#)

Évaluation de la perte de vision aiguë

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit décrire la perte de vision en termes d'apparition, durée, progression et localisation (si elle est monoculaire ou binoculaire et si elle implique la totalité du champ visuel ou une partie spécifique et laquelle). Les symptômes visuels importants associés comprennent les [corps flottants](#), des éclairs, des halos autour des lumières, des anomalies de la vision des couleurs et une vision déformée ou en mosaïque (scotome scintillant). Il faut demander au patient s'il ressent une douleur oculaire et si elle est constante ou ne survient qu'aux mouvements des globes.

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes extra-oculaires de causes possibles de baisse de vision, telles que la claudication de la mâchoire ou de la langue, des céphalées temporales, des douleurs musculaires et une raideur proximale ([artérite à cellules géantes](#)); et des hémicrânes (migraines ophtalmiques).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur des facteurs de risque connus de troubles oculaires (p. ex., le port de lentilles de contact, une myopie sévère, une chirurgie, une injection, ou une blessure oculaires récentes), les facteurs de risque de maladies vasculaires (p. ex., [diabète](#), [HTA](#)) et de troubles hématologiques (p. ex., [drépanocytose](#) ou maladies telles que la [macrolobulinémie de Waldenström](#) ou le [myélome multiple](#) qui pourraient provoquer un syndrome d'hyperviscosité).

Les antécédents familiaux de [migraines](#) doivent être notés.

Examen clinique

Les signes vitaux, dont la température, sont mesurés.

Si le diagnostic envisagé est un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire, [occlusion de l'artère centrale de la rétine](#)) se présentant comme une amaurose fugace, un examen neurologique complet est effectué. Les tempes sont palpées à la recherche du pouls, d'une sensibilité ou de nodosités sur le trajet de l'artère temporale. Cependant, la plus grande part de l'examen se concentre sur l'œil.

L'**examen clinique des yeux** comprend les éléments suivants:

- L'acuité visuelle est mesurée.
- Les champs visuels périphériques sont évalués par comparaison.
- Les champs visuels centraux sont évalués à l'aide de la grille d'Amsler.
- Les réflexes pupillaires direct et consensuel à la lumière sont examinés en utilisant le test de l'éclairement alterné à la lampe stylo.
- La motricité oculaire est évaluée.
- La vision des couleurs est testée avec des plaques de couleur.
- Les paupières, la sclère et la conjonctive sont examinées en utilisant une lampe à fente si possible.
- La cornée est examinée avec la coloration à la fluorescéine.
- La chambre antérieure est examinée à la recherche de cellules et du signe de Tyndall en cas de douleurs oculaires ou d'œil rouge.
- Le cristallin est vérifié à la recherche d'une cataracte en utilisant l'ophtalmoscope direct et/ou la lampe à fente.
- La pression intraoculaire est mesurée.
- Le fond de l'œil est examiné, de préférence après dilatation de la pupille par une goutte d'un sympathomimétique (p. ex., phényléphrine à 2,5%), et/ou d'un cycloplégique (p. ex., cyclopentolate à 1% ou tropicamide à 1%); la dilatation est presque complète en environ 20 min. La totalité du fond d'œil est examinée dont la rétine, la macula, la fovéa, les vaisseaux, la papille et ses bords.
- Si les réflexes pupillaires sont normaux et si une baisse de la vision non organique est suspectée (rarement), on peut vérifier la présence du nystagmus optocinétique. Si on ne dispose pas d'un tambour optocinétique, on peut tenir un miroir près de l'œil du patient et le bouger lentement. Si le patient peut voir, les yeux suivent habituellement les mouvements du miroir (on considère qu'on est en présence d'un nystagmus optocinétique).

Signes d'alarme

Une baisse brutale de la vision est en elle-même un signe d'alarme; la plupart de ses causes sont graves.

Interprétation des signes

L'évaluation d'une perte de vision aiguë doit être effectuée de manière systématique. Des profils spécifiques d'[atteinte du champ visuel](#) peuvent orienter vers une cause. D'autres signes cliniques peuvent également suggérer une cause à la [perte de vision aiguë](#):

- Une difficulté à voir le reflet rouge de la pupille à l'ophtalmoscope suggère une opacification des milieux transparents (p. ex., provoquée par un [ulcère cornéen](#), une hémorragie du vitré ou une [endophtalmie](#) grave).
- Les [déficits spécifiques du champ visuel](#) suggèrent certaines causes (p. ex., décollement rétinien partiel, occlusion de l'artère rétinienne)
- Les lésions rétinienne qui sont assez graves pour provoquer une perte brutale de la vision sont détectables à l'examen du fond de l'œil, en particulier si les pupilles sont dilatées. Un [décollement de la rétine](#) peut apparaître comme un parachute gonflé et pâle; une occlusion veineuse rétinienne peut montrer des hémorragies rétinienne caractéristiques (1); l'occlusion artérielle rétinienne peut montrer la rétine pâle avec une fovéa rouge cerise (2).
- Un déficit de l'afférent pupillaire (absence de réponse pupillaire à la lumière directe mais réponse normale consensuelle) avec un examen par ailleurs normal (à l'exception parfois d'une papille optique anormale) suggère une anomalie du nerf optique ou de la rétine (c'est-à-dire, antérieure au chiasma optique).

De plus, les signes cliniques suivants peuvent également aider à suggérer une cause:

- Les symptômes monoculaires suggèrent une lésion en avant du chiasma optique.
- Des anomalies bilatérales et symétriques (homonymes) du champ visuel suggèrent une lésion située derrière le chiasma (p. ex., un AVC du lobe occipital).
- Une douleur oculaire constante suggère une lésion cornéenne (ulcère ou érosion), une inflammation de la chambre antérieure ou une augmentation de la pression intraoculaire alors qu'une douleur liée aux mouvements du globe suggère une névrite optique.
- Des céphalées temporales suggèrent une artérite à cellules géantes ou une migraine.

Examens complémentaires

Des tests supplémentaires sont inclus dans le tableau [Certaines causes de perte brutale de la vision](#). Ceux qui suivent sont de particulière importance:

- Une vitesse de sédimentation érythrocytaire, un dosage de la protéine C réactive, et une mesure du nombre de plaquettes sont pratiqués chez tous les patients symptomatiques (p. ex., céphalée temporale, claudication de la mâchoire, myalgies proximales, raideur) ou des signes cliniques (p. ex., douleur ou induration de l'artère temporale, rétine pâle, œdème papillaire) suggérant une ischémie du nerf optique ou de la rétine (3,4).
- Une échographie est réalisée pour évaluer la rétine lorsqu'elle est mal visible à l'examen du fond d'œil après dilatation pupillaire et ophtalmoscopie indirecte effectuée par un ophtalmologiste.
- Une IRM cérébrale et des orbites rehaussée au gadolinium est réalisée chez les patients présentant des douleurs oculaires lors des mouvements ou un déficit de l'afférent pupillaire, particulièrement en présence d'un œdème papillaire à l'ophtalmoscopie, pour diagnostiquer une [sclérose en plaques](#).
- IRM ou TDM en cas de suspicion d'ischémie vasculaire (p. ex., artère rétinienne centrale) (2).
- Si la pression intraoculaire est élevée, un glaucome par fermeture d'angle aigu doit être suspecté (5).

Références pour l'évaluation

- [Kovach JL, Bailey ST, Kim SJ, et al. Retinal Vein Occlusions Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2025;132\(4\):P303-P343. doi:10.1016/j.ophtha.2024.12.025](#)
- [Kovach JL, Bailey ST, Kim SJ, et al. Retinal and Ophthalmic Artery Occlusions Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2025;132\(4\):P270-P302. doi:10.1016/j.ophtha.2024.12.024](#)
- [Bajpai V, Madan S, Beri S. Arteritic anterior ischaemic optic neuropathy: An update. Eur J Ophthalmol. 2021;31\(6\):2818-2827. doi:10.1177/11206721211009447](#)
- [Hayreh SS. Ischemic optic neuropathy. Prog Retin Eye Res. 2009;28\(1\):34-62. doi:10.1016/j.preteyeres.2008.11.002](#)
- [Gedde SJ, Chen PP, Muir KW, et al. Primary Angle-Closure Disease Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2021;128\(1\):P30-P70. doi:10.1016/j.ophtha.2020.10.021](#)

Traitement de la perte de vision aiguë

Les troubles causals sont traités. Une consultation urgente en ophtalmologie est requise pour la plupart des patients présentant une perte de vision aiguë.

Le traitement doit habituellement être entrepris en urgence si la cause est traitable. Dans de nombreux cas (p. ex., occlusions artérielles), il n'y a pas de traitement qui puisse sauver l'œil atteint mais il peut réduire le risque de survenue du même processus dans l'œil controlatéral ou d'une complication causée par le même processus (p. ex., un accident vasculaire cérébral ischémique).

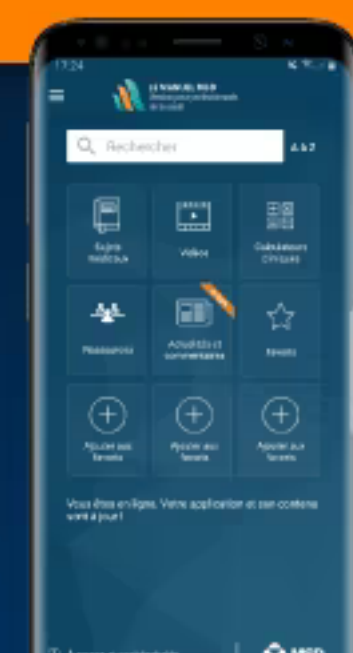
Points clés

- Le diagnostic et le traitement doivent être effectués aussi rapidement que possible.
- Adressage immédiat vers un centre spécialisé en accidents vasculaires cérébraux si un événement embolique aigu est suspecté (p. ex., amaurose fugace, occlusion de l'artère rétinienne, accident vasculaire cérébral ischémique).
- Consultation ophtalmologique urgente dans le cas de la plupart des patients présentant une perte de vision aiguë.
- Une perte brutale de la vision unilatérale avec un déficit de l'afférent pupillaire indique une lésion de l'œil ou du nerf optique antérieure au chiasma optique.
- Une lésion du nerf optique, notamment ischémique, est évoquée en cas de perte de vision monoculaire ou de déficit de l'afférent pupillaire sans douleur oculaire, et en présence ou non d'anomalies de la papille au fond d'œil, mais pas d'autre lésion à l'examen de l'œil.
- Un ulcère cornéen, un [glaucome aigu par fermeture de l'angle](#), une [endophtalmie](#) ou une [uvéite](#) antérieure sévère sont évoqués en cas de perte visuelle brutale unilatérale aiguë, de douleurs oculaires et d'injection conjonctivale.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Take a Quiz!

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD



Scannez le code pour télécharger dès maintenant

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

